

# ENCÉPHALOPATHIE HÉPATIQUE CHEZ L'ENFANT

## 1. DÉFINITION

L'encéphalopathie hépatique (EH) est un dysfonctionnement neurologique résultant d'une insuffisance hépatique aiguë ou chronique, entraînant une accumulation de toxines neurotoxiques (ammoniac, acides gras à chaîne courte) dans le système nerveux central.

## 2. ÉTIOLOGIES CHEZ L'ENFANT

- **Causes aiguës :**
  - Insuffisance hépatique aiguë (hépatites virales, toxiques, syndrome de Reye, maladie de Wilson).
  - Insuffisance hépatique fulminante (intoxication au paracétamol, infection virale sévère).
- **Causes chroniques :**
  - Cirrhose d'origine métabolique, auto-immune ou post-infectieuse.
  - Shunt porto-systémique congénital.

## 3. CLINIQUE

| Signes                     | Nourrissons                           | Enfants plus grands                  |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Troubles du comportement   | Irritabilité, pleurs inexpliqués      | Confusion, troubles de l'attention   |
| Troubles du tonus          | Hypotonie ou hypertonie               | Astérixis (flapping tremor)          |
| Altération de la vigilance | Léthargie, somnolence excessive       | Troubles du sommeil, apathie         |
| Crises convulsives         | Possibles, surtout aux stades avancés | Plus rares mais possibles            |
| Troubles moteurs           | Retard moteur, hypertonie spastique   | Désorientation, marche instable      |
| Signes digestifs           | Vomissements, anorexie                | Nausées, douleurs abdominales        |
| Ictère                     | Peau et conjonctives jaunâtres        | Fréquent en cas d'atteinte hépatique |

## 4. DIAGNOSTIC

- **Biologie :**
  - Ammoniémie élevée ( $> 100 \mu\text{mol/L}$ ).
  - Tests hépatiques : ALAT/ASAT, bilirubine, INR, facteur V.
  - Glycémie, lactates, ionogramme.
  - Recherche de métabolopathies (maladie de Wilson, aciduries organiques).
- **Neuro-imagerie :** IRM cérébrale pour rechercher un oedème cérébral.

## 5. PRISE EN CHARGE

- **Stabilisation :**
  - Contrôle des fonctions vitales en réanimation.
  - Prévention et traitement de l'œdème cérébral (hyperventilation, mannitol, élévation de la tête).
- **Traitement étiologique :**
  - Acétylcystéine si intoxication au paracétamol.
  - Plasmaphérèse ou albumine si hépatite fulminante.
  - Transplantation hépatique si insuffisance hépatique terminale.
- **Traitement symptomatique :**

- Réduction de l'ammoniémie (lactulose, antibiotiques type rifaximine pour diminuer la flore productrice d'ammoniac).
- Correction des troubles électrolytiques et de la glycémie.

## **6. PRONOSTIC ET PRÉVENTION**

- Pronostic grave, surtout aux stades avancés.
- Prévention par la vaccination contre l'hépatite B, une surveillance des enfants atteints de maladies métaboliques, et une limitation des substances hépatotoxiques (paracétamol, toxines).